

Repercussões sistêmicas do hipoestrogenismo: tópicos 3, 4 e 5

Oct 8, 2026 · @Daniel Cardoso De

Formato

15 slides, 5 por tópico. Cada slide trabalha um tópico estruturante e traz o conteúdo da tela e a fala sugerida. No fim de cada tópico há perguntas que a banca pode fazer, com respostas.

Tópico 3: Risco cardiovascular e metabolismo lipídico

Transição e cuidado preventivo

Slide 3.1: O risco cardiovascular da mulher tem várias causas

Tópico estruturante: risco cardiovascular é multifatorial

Conteúdo do slide

- A doença cardiovascular (DCV) é a principal causa de morte em mulheres no Brasil e no mundo, à frente de todos os cânceres somados.
- Até a menopausa, a mulher costuma ter menos eventos que o homem da mesma idade. Depois, essa diferença diminui de forma progressiva.
- O hipoestrogenismo pesa, mas não decide sozinho. Os determinantes são:
 - **Não modificáveis:** idade, genética, história familiar de DCV precoce (parente de 1º grau homem com menos de 55 anos ou mulher com menos de 65), etnia.
 - **Modificáveis:** hipertensão arterial, diabetes, dislipidemia, tabagismo, sedentarismo, obesidade (sobretudo a central), alimentação e sono.
 - **Psicossociais e estruturais:** estresse crônico, depressão, baixa renda e escolaridade, racismo estrutural, insegurança alimentar, dificuldade de acesso ao serviço de saúde.
 - **Específicos da mulher:** menopausa precoce (antes dos 45 anos) e insuficiência ovariana prematura (antes dos 40), pré-eclâmpsia, diabetes gestacional, SOP, doenças autoimunes (LES, artrite reumatoide).
- A DCV na mulher ainda é subdiagnosticada e subtratada: os sintomas de síndrome coronariana costumam ser menos típicos (dispneia, fadiga, náusea, dor epigástrica), e tanto o profissional quanto a paciente percebem menos o risco.

Fala sugerida

"O ponto de partida é que a menopausa não 'causa' infarto. Ela entra numa rede de fatores que se somam. Para a mesma queda de estrogênio, a mulher tabagista, hipertensa e sedentária tem um risco completamente diferente da mulher ativa, normotensa e com boa rede de apoio. Explicar o risco só pelo hormônio leva a erros de prevenção."

Slide 3.2: A transição menopausal muda lipídios, gordura corporal e vasos

Tópico estruturante: o metabolismo lipídico pode se modificar

Conteúdo do slide

- O que o estrogênio faz no sistema cardiovascular:
 - Vasodilatação pela via do receptor $ER\alpha$, que ativa a eNOS e aumenta o óxido nítrico.
 - Ação anti-inflamatória e antioxidante, com menor expressão de moléculas de adesão (VCAM-1, ICAM-1).
 - No fígado, aumenta os receptores de LDL, o que eleva a depuração do LDL-c.
 - Favorece a gordura de padrão subcutâneo, glúteo-femoral (ginoide).
- O que muda no hipoestrogenismo:
 - **Lipídios:** o estudo SWAN mostrou aumento de LDL-c e ApoB de cerca de 10 a 15% concentrado em torno da última menstruação, independentemente do envelhecimento. Os triglicerídeos sobem. A Lp(a) pode aumentar. O HDL-c pode até subir em número, mas perde funcionalidade (menor efluxo de colesterol), o que torna o "HDL alto" menos protetor.
 - **Composição corporal:** a gordura se redistribui para o abdome (padrão androide, visceral) e a massa magra diminui (sarcopenia), mesmo com peso estável.
 - **Metabolismo glicídico:** aumenta a resistência à insulina e o risco de síndrome metabólica.
 - **Vasos:** surgem disfunção endotelial, aumento da rigidez arterial e da pressão arterial, e progressão da espessura médio-intimal da carótida.

Fala sugerida

"O SWAN, coorte longitudinal multiétnica, mostrou que a alteração lipídica se concentra no ano em torno da menopausa, o que sugere um efeito próprio da transição e não só da idade. Mesmo assim, esse perfil é um risco que se modifica com intervenção, e não um destino."

Slide 3.3: Sedentarismo e tabagismo, os fatores mais modificáveis

Tópico estruturante: sedentarismo e tabagismo aumentam o risco

Conteúdo do slide

- **Tabagismo:**
 - Causa lesão endotelial, estado pró-trombótico, oxidação do LDL e redução do HDL.
 - Tem efeito antiestrogênico: acelera o metabolismo hepático do estradiol e é tóxico para os folículos. Por isso antecipa a menopausa em 1 a 2 anos e intensifica os fogachos.
 - O risco relativo de infarto associado ao tabagismo é proporcionalmente maior na mulher que no homem.
 - Parar de fumar reduz de forma importante o risco coronariano já nos primeiros anos.
- **Sedentarismo:**
 - Piora a resistência à insulina, o acúmulo de gordura visceral, a pressão arterial e o perfil lipídico, e acelera a perda muscular e óssea.
 - Recomendação (OMS): 150 a 300 minutos por semana de atividade aeróbica moderada, ou 75 a 150 minutos de atividade vigorosa, mais exercício de força em 2 ou mais dias por semana. A força é fundamental no climatério, para músculo, osso e glicemia.
 - Reduzir o tempo sentado também conta.
- **Fatores que se somam:** alimentação ultraprocessada, consumo de álcool, sono curto ou de má qualidade e estresse crônico.

Fala sugerida

"O tabagismo é o exemplo mais claro de como o comportamento e o hormônio se cruzam. O cigarro reduz o estrogênio, antecipa a menopausa e ainda lesa diretamente o endotélio. Ou seja, um fator modificável agrava o próprio hipoestrogenismo."

Slide 3.4: A prevenção começa antes da menopausa

Tópico estruturante: a prevenção deve começar precocemente

Conteúdo do slide

- A aterosclerose é um processo de décadas. O que se faz na vida reprodutiva e na perimenopausa define o risco aos 60 ou 70 anos.
- Valorizar a história ginecológica e obstétrica como marcador de risco: pré-eclâmpsia, hipertensão gestacional, diabetes gestacional, parto prematuro, SOP e menopausa precoce ou IOP são potencializadores de risco reconhecidos pelas diretrizes.

- **Estratificar o risco:**

- Usar escores validados: o Escore de Risco Global da SBC e as equações PREVENT da AHA (2023).
- Ajustar a estratificação pelos potencializadores de risco específicos da mulher.
- Pedir os exames iniciais: perfil lipídico, glicemia ou HbA1c, função renal, aferição correta da PA, circunferência abdominal e IMC.

- **Terapia hormonal da menopausa (THM): o que a banca vai perguntar**

- A THM não está indicada para prevenção cardiovascular, nem primária nem secundária. Sua indicação é o tratamento de sintomas, sobretudo os vasomotores.
- Hipótese da janela de oportunidade: o WHI incluiu mulheres em média com 63 anos e mostrou aumento de eventos. Estudos e reanálises em mulheres com menos de 60 anos ou com menos de 10 anos de menopausa (ELITE, KEEPS, subanálises do WHI) mostraram perfil neutro ou favorável.
- Contraindicações cardiovasculares: doença coronariana estabelecida, AVC, tromboembolismo venoso prévio. Se houver indicação, a via transdérmica tem menor risco trombótico.

Fala sugerida

"A gestação funciona como um 'teste de estresse' cardiovascular natural. A mulher que teve pré-eclâmpsia aos 30 anos precisa ser lembrada aos 45. E a pergunta clássica da banca: THM previne infarto? Não. A indicação é sintomática, e a decisão é individualizada, levando em conta idade, tempo de menopausa e risco basal."

Slide 3.5: O climatério como oportunidade de promover saúde

Tópico estruturante: o climatério é oportunidade de promoção da saúde

Conteúdo do slide

- Nessa fase, a mulher procura o serviço por causa dos sintomas, e esse contato é o momento de abordar a saúde cardiovascular.
- "Life's Essential 8" (AHA) como roteiro prático: alimentação, atividade física, tabagismo, sono, peso, colesterol, glicemia e pressão arterial.
- **Plano de cuidado:**
 - Alimentação: padrão mediterrâneo ou DASH, menos ultraprocessados, sódio e açúcares, mais fibras, de acordo com o Guia Alimentar para a População Brasileira.
 - Atividade física: aeróbica e de força.
 - Cessação do tabagismo: abordagem breve, terapia cognitivo-comportamental e farmacoterapia pelo Programa Nacional de Controle do Tabagismo do SUS.

- Controle dos fatores de risco: meta pressórica habitualmente abaixo de 130/80 mmHg em quem tem risco elevado; meta de LDL conforme o risco; estatina quando indicada.
- Sono e saúde mental como componentes do risco cardiovascular.
- Cuidado longitudinal na Atenção Primária, com equipe multiprofissional (nutrição, educação física, psicologia) e Academia da Saúde.
- Educação em saúde e autonomia: decisão compartilhada, metas realistas e respeito ao contexto socioeconômico. Prescrever "academia" para quem não tem tempo nem renda é uma recomendação desconectada da vida real.

Fala sugerida

"Fecho o tópico 3 com a ideia de que o climatério não é só um período de risco, é uma oportunidade estratégica. A paciente que chega por causa do fogacho sai com a pressão aferida, o tabagismo abordado e um plano de atividade física possível dentro da realidade dela."

Possíveis perguntas da banca (tópico 3)

1. **Por que o HDL alto pode não proteger na pós-menopausa?** Porque o HDL perde funcionalidade (capacidade de efluxo de colesterol e ação anti-inflamatória). O que protege é a função, não só a concentração.
2. **Explique a janela de oportunidade.** O efeito vascular do estrogênio depende de o endotélio ainda estar saudável. Quando já existe placa estabelecida, o estrogênio pode desestabilizá-la e favorecer a trombose.
3. **Cite potencializadores de risco cardiovascular específicos da mulher.** Pré-eclâmpsia, diabetes gestacional, SOP, menopausa precoce ou IOP e doenças autoimunes.

Tópico 4: Saúde mental, sono e sintomas subjetivos

Escuta e validação

Slide 4.1: Sono e sintomas vasomotores

Tópico estruturante: o sono pode ser afetado por sintomas vasomotores

Conteúdo do slide

- De 40 a 60% das mulheres na transição menopausal referem queixas de sono: dificuldade para iniciar o sono, despertares frequentes e sono não reparador.

- **Fisiopatologia dos fogachos:** a queda do estrogênio leva à hipertrofia dos neurônios KNDy (kisspeptina, neurocinina B, dinorfina) no hipotálamo. O sinal da neurocinina B pelo receptor NK3 fica exagerado, a zona termoneutra se estreita e surgem episódios de calor, sudorese e taquicardia.
- Os suores noturnos causam despertares, o sono se fragmenta, e vêm fadiga, irritabilidade e dificuldade de concentração no dia seguinte.
- **Outras causas que não se pode deixar passar:**
 - Apneia obstrutiva do sono: a prevalência aumenta após a menopausa, pela perda do efeito estimulante respiratório da progesterona e pela redistribuição de gordura. Muitas vezes se manifesta como insônia e fadiga, sem o ronco "clássico". Rastrear com STOP-BANG.
 - Síndrome das pernas inquietas, noctúria (relacionada à SGM), dor crônica, depressão e ansiedade, medicamentos, álcool, cafeína e uso de telas.
- **Abordagem:** a TCC-I (terapia cognitivo-comportamental para insônia) é a primeira linha. Tratar os sintomas vasomotores quando indicado, com THM ou opções não hormonais (ISRS/IRSN em dose baixa, gabapentina, antagonistas de NK3 como fezolinetante e elinzanetante). Evitar o uso crônico de benzodiazepínicos.

Fala sugerida

"A insônia do climatério não é um diagnóstico único. Ela pode vir do fogacho, da apneia, da depressão ou da sobrecarga da vida. Por isso a anamnese do sono precisa ser detalhada antes de qualquer prescrição."

Slide 4.2: Queixas emocionais: acolher e reconhecer a janela de vulnerabilidade

Tópico estruturante: as queixas emocionais devem ser acolhidas

Conteúdo do slide

- **Janela de vulnerabilidade:** na perimenopausa, o risco de sintomas depressivos é cerca de 2 a 4 vezes maior (SWAN e Penn Ovarian Aging Study), inclusive em mulheres sem história prévia de depressão.
- **Mecanismos propostos:**
 - A flutuação do estradiol, mais do que o nível baixo em si, interfere na neurotransmissão serotoninérgica, noradrenérgica e GABAérgica.
 - Hipótese do dominó: fogachos levam a insônia, que leva a sintomas depressivos.
 - Sensibilidade hormonal individual: mulheres com história de TDPM ou de depressão pós-parto têm maior risco.
- **Queixas frequentes:** irritabilidade, ansiedade, labilidade emocional, choro fácil, fadiga e anedonia.

- **Queixas cognitivas ("névoa mental"):** dificuldade de concentração e de memória verbal. Os dados do SWAN indicam que esse quadro tende a ser transitório, com recuperação na pós-menopausa. Ainda assim, um declínio progressivo exige investigação (afastar depressão, hipotireoidismo, deficiência de B12 e demência).
- Acolher significa reconhecer que o sintoma é real, sem minimizar ("é só a idade") e sem dramatizar.

Fala sugerida

"Do ponto de vista biológico há, sim, uma janela de maior vulnerabilidade. Isso dá legitimidade à queixa da mulher. Validar não é concordar que tudo é hormonal, é reconhecer que o sofrimento existe e merece cuidado."

Slide 4.3: O sofrimento não se explica só por hormônios

Tópico estruturante: o sofrimento não deve ser reduzido a hormônios

Conteúdo do slide

- **O risco de duas reduções opostas:**
 - Atribuir tudo à menopausa ("é hormonal"), o que leva a perder diagnósticos como depressão maior, transtorno bipolar, transtorno de ansiedade, violência doméstica e uso de álcool.
 - Descartar a menopausa ("é psicológico"), o que leva a deixar de tratar sintomas vasomotores que alimentam a insônia e o humor deprimido.
- **Diagnósticos diferenciais obrigatórios:** hipotireoidismo e hipertireoidismo, anemia, deficiência de B12 e vitamina D, apneia do sono, diabetes, efeitos adversos de medicamentos, luto e transtornos de humor primários.
- **A THM não é antidepressivo.** Há evidência de benefício no humor na perimenopausa com sintomas vasomotores, mas a depressão maior deve ser tratada como depressão maior, com psicoterapia e antidepressivo.
- **Sinais de alerta que pedem encaminhamento ou manejo especializado:** ideação suicida, sintomas psicóticos, prejuízo funcional grave, suspeita de bipolaridade, uso abusivo de substâncias.
- **Estereótipos a evitar:** a "mulher histérica" e a "louca da menopausa". Esses estereótipos historicamente silenciaram queixas legítimas das mulheres.

Fala sugerida

"O raciocínio clínico correto é de soma, não de exclusão: o hormônio pode contribuir, e outros fatores também contribuem. O estudante precisa sair daqui sabendo pesquisar ideação suicida numa consulta de climatério, porque isso salva vidas."

Slide 4.4: O contexto social e a saúde mental

Tópico estruturante: o contexto social influencia a saúde mental

Conteúdo do slide

- **O climatério coincide com uma fase de grandes demandas de vida:**
 - A chamada "geração sanduíche": cuidado com filhos e com pais idosos ao mesmo tempo.
 - Dupla ou tripla jornada (trabalho remunerado, doméstico e de cuidado).
 - Pressão no trabalho, risco de desemprego, aposentadoria.
 - Mudanças familiares: saída dos filhos de casa, divórcio, viuvez, luto.
 - Surgimento de doenças crônicas próprias ou na família.
- **Determinantes sociais:** renda, escolaridade, raça/cor e território. Mulheres negras e de baixa renda têm sintomas vasomotores mais intensos e prolongados (SWAN) e menos acesso a cuidado.
- **Violência contra a mulher:** pode ser a causa oculta de insônia, ansiedade e depressão. Perguntar ativamente e conhecer a rede de proteção.
- **Fatores culturais:** em culturas que valorizam a juventude, a menopausa pode ser vivida como perda. Em outras, como libertação. A forma como a mulher vive essa fase também é construída socialmente.
- **Fatores de proteção:** rede de apoio, vínculo com a equipe de saúde, participação social, atividade física e espiritualidade.

Fala sugerida

"Duas mulheres com o mesmo estradiol podem viver o climatério de formas opostas. Uma tem rede de apoio e autonomia financeira, a outra cuida sozinha da mãe com Alzheimer e trabalha em dois empregos. O contexto não é pano de fundo, ele faz parte do diagnóstico."

Slide 4.5: Escuta qualificada: do acolhimento ao plano de cuidado

Tópico estruturante: escuta qualificada é indispensável

Conteúdo do slide

- **Método Clínico Centrado na Pessoa (MCCP).** Explorar a doença e a experiência de adoecer pelo SIFE:
 - Sentimentos: "Como a senhora tem se sentido?"
 - Ideias: "O que acha que está causando isso?"
 - Funcionalidade: "Como isso afeta seu dia a dia?"
 - Expectativas: "O que espera desta consulta?"
- **Habilidades de comunicação:** perguntas abertas, escuta sem interrupção precoce, empatia verbal ("Faz sentido a senhora estar cansada com tudo isso"), resumo e checagem.
- **Instrumentos de apoio,** que complementam a escuta e não a substituem:
 - PHQ-2 e PHQ-9 (depressão) e GAD-7 (ansiedade).
 - Escala de Kupperman ou MRS (Menopause Rating Scale) para os sintomas climatéricos.
 - ISI (Índice de Gravidade da Insônia) e STOP-BANG.
- **Conduta escalonada:**
 1. Acolher e explicar a fisiologia (educação em saúde reduz a ansiedade).
 2. Orientar hábitos: higiene do sono, atividade física, menos álcool e cafeína.
 3. Tratar os sintomas vasomotores quando indicado.
 4. Oferecer psicoterapia, grupos na APS e práticas integrativas (PICS).
 5. Usar farmacoterapia quando indicada.
 6. Encaminhar para a RAPS (CAPS ou psiquiatria) em casos graves.
- **Cuidado longitudinal:** retorno programado, vínculo e coordenação do cuidado.

Fala sugerida

"A escuta qualificada é uma competência técnica, não um 'extra' de gentileza. Ela aumenta a precisão diagnóstica, a adesão e a satisfação, e é o que impede que o sofrimento da mulher seja reduzido a um estereótipo."

Possíveis perguntas da banca (tópico 4)

1. **Qual a primeira linha para a insônia crônica?** TCC-I.
2. **Qual é o alvo dos novos fármacos não hormonais para fogachos?** O receptor NK3 da neurocinina B no hipotálamo (fezolinetante, elinzanetante).
3. **Toda depressão no climatério é hormonal?** Não. A transição aumenta a vulnerabilidade, mas é preciso fazer o diagnóstico diferencial, avaliar o contexto e tratar a depressão maior segundo os critérios próprios dela.

Tópico 5: Sexualidade e envelhecimento saudável

Autonomia, prazer e qualidade de vida

Slide 5.1: A sexualidade continua importante no envelhecimento

Tópico estruturante: a sexualidade permanece relevante no envelhecimento

Conteúdo do slide

- **Conceito da OMS:** a sexualidade é um aspecto central do ser humano ao longo de toda a vida. Envolve sexo, identidade, orientação, erotismo, prazer, intimidade e reprodução. Não se resume à relação genital nem à frequência de relações.
- **Modelos de resposta sexual:**
 - Masters e Johnson e Kaplan: modelo linear (desejo, excitação, orgasmo, resolução).
 - Basson (2000): modelo circular, especialmente aplicável a mulheres em relacionamentos longos e no climatério. A motivação pode partir da intimidade emocional, e o desejo pode ser responsivo (surge depois do estímulo, e não antes dele).
- **Evidência:** muitas mulheres continuam sexualmente ativas e satisfeitas após os 60 e 70 anos. Desejo menor não significa, por si só, disfunção.
- **Disfunção sexual (DSM-5)** exige sofrimento pessoal significativo e duração de pelo menos 6 meses. Sem sofrimento, não há doença a tratar.
- **Mito a desconstruir:** a "pessoa idosa assexuada".

Fala sugerida

"O modelo de Basson muda a lógica da consulta. Uma mulher que diz 'não sinto vontade espontânea, mas quando começa é bom' não necessariamente tem disfunção. Ela pode estar descrevendo um desejo responsivo, que é absolutamente normal."

Slide 5.2: Síndrome geniturinária da menopausa (SGM)

Tópico estruturante: sintomas geniturinários podem interferir no conforto

Conteúdo do slide

- **Definição (ISSWSH/NAMS, 2014):** conjunto de sinais e sintomas vulvovaginais e urinários causados pelo hipoestrogenismo. O termo substituiu "atrofia vulvovaginal".
- Afeta cerca de 50 a 70% das mulheres pós-menopausa. Ao contrário dos fogachos, é progressiva e não melhora espontaneamente, e é muito subnotificada (vergonha e falta de pergunta ativa).

- **Fisiopatologia:** a mucosa afina, a lubrificação e a elasticidade diminuem, os lactobacilos se reduzem, o pH vaginal sobe para mais de 4,5 e o fluxo sanguíneo cai.
- **Sintomas:**
 - Genitais: secura, ardor, prurido.
 - Sexuais: dispareunia, sangramento pós-coito, menos lubrificação.
 - Urinários: urgência, disúria, ITU de repetição.
- **Ciclo da dor:** dispareunia leva a antecipação da dor, que leva a menos excitação e lubrificação, mais dor, evitação e queda do desejo.
- **Tratamento escalonado:**
 1. Lubrificantes (na relação) e hidratantes vaginais (uso regular).
 2. Estrogênio vaginal em baixa dose, com absorção sistêmica mínima e boa segurança.
 3. Prasterona (DHEA) vaginal e ospemifeno.
 4. Fisioterapia pélvica.
 5. Estímulo à atividade sexual, que ajuda a manter o trofismo.

Fala sugerida

"A SGM é o melhor exemplo de que uma queixa sexual pode ter base orgânica tratável, e é simples tratá-la. Mas se o médico não pergunta, a mulher sofre em silêncio, muitas vezes por anos."

Slide 5.3: Autoimagem, corpo e fatores que influenciam a vida sexual

Tópico estruturante: a autoimagem influencia a vida sexual

Conteúdo do slide

- **Mudanças no corpo:** ganho de peso, gordura abdominal, mudanças na pele, nos cabelos e nas mamas. Sobre tudo em uma cultura que associa beleza e desejo à juventude, isso pode afetar a autoestima e a disposição para a intimidade.
- **Fatores biopsicossociais que modulam a sexualidade:**
 - Biológicos: hipoestrogenismo, redução de androgênios com a idade, SGM, incontinência urinária, prolapso, doenças crônicas (diabetes, DCV, câncer de mama e mastectomia, depressão), dor crônica.
 - Medicamentos: ISRS e IRSN, betabloqueadores, diuréticos tiazídicos, antiandrogênicos, inibidores de aromatase, tamoxifeno, benzodiazepínicos.
 - Psicológicos: depressão, ansiedade, imagem corporal, história de abuso.
 - Relacionais: qualidade do vínculo, comunicação, conflitos, saúde do parceiro (disfunção erétil, por exemplo), ausência de parceria.

- Socioculturais: religião, educação sexual recebida, tabus sobre a sexualidade da mulher mais velha.
- **Intervenções:** fortalecer a autoestima, praticar atividade física (melhora a imagem corporal e o humor), oferecer espaço para falar sobre o corpo e rever medicamentos.
- **Testosterona:** o Consenso Global de 2019 aceita apenas para o transtorno do desejo sexual hipoativo na pós-menopausa, após avaliação criteriosa. Não há formulação feminina aprovada no Brasil, e o uso estético ou "anabolizante" deve ser desencorajado.

Fala sugerida

"A sexualidade é biopsicossocial por excelência. Antes de pensar em hormônio, o médico precisa perguntar: quais remédios ela usa? Como está o relacionamento? Como ela se sente em relação ao próprio corpo?"

Slide 5.4: Cuidado sem julgamento: como abordar a sexualidade na consulta

Tópico estruturante: o cuidado deve ser sem julgamento

Conteúdo do slide

- **Barreiras do profissional:** desconforto, falta de tempo, falta de formação e pressupostos (idade, heteronormatividade, estado civil).
- **Como iniciar a conversa (normalizar e pedir permissão):**
 - "Muitas mulheres nessa fase notam mudanças na vida sexual. Posso perguntar como está isso para a senhora?"
 - Usar linguagem neutra ("parceria") e não presumir orientação sexual nem relação monogâmica.
- **Modelo PLISSIT (Annon, 1976):**
 - P, permissão: legitimar o tema.
 - LI, informação limitada: explicar as mudanças fisiológicas.
 - SS, sugestões específicas: lubrificante, mais tempo de preliminares, mudança de posição, tratamento da SGM.
 - IT, terapia intensiva: terapia sexual ou de casal, quando necessário.
- **Prevenção de ISTs na mulher mais velha:** a incidência de sífilis e HIV vem aumentando em pessoas com mais de 50 anos no Brasil. A falta de risco de gravidez e a mucosa mais frágil favorecem a exposição. Oferecer testagem rápida, preservativo e PEP/PrEP quando indicado.
- **Diversidade:** mulheres lésbicas, bissexuais e trans, sem parceria, viúvas, com deficiência. Cada trajetória é legítima, inclusive a opção de não ter vida sexual.
- **Ética:** confidencialidade, respeito à autonomia e atenção a sinais de violência sexual.

Fala sugerida

"Não julgar inclui não presumir: não presumir que ela é heterossexual, que tem marido, que não tem risco de IST porque tem 60 anos, ou que deveria querer ter relações. O papel do médico é abrir a porta, não empurrar a paciente por ela."

Slide 5.5: Envelhecimento saudável: autonomia, vínculo e qualidade de vida

Tópico estruturante: envelhecimento saudável envolve autonomia e vínculo

Conteúdo do slide

- **Conceito da OMS (Década do Envelhecimento Saudável, 2021–2030):**
envelhecimento saudável é desenvolver e manter a capacidade funcional que permite o bem-estar. Ele resulta da capacidade intrínseca (física e mental) em interação com o ambiente.
- **Envelhecimento ativo (OMS, 2002)** tem quatro pilares: saúde, participação, segurança e aprendizagem ao longo da vida.
- **Integração com os tópicos anteriores:**
 - Saúde cardiovascular e metabólica (tópico 3).
 - Saúde mental e sono (tópico 4).
 - Sexualidade e intimidade (tópico 5).
 - Saúde óssea e muscular (tópico 2).
 - Todos dependem de hábitos, vínculo e acesso ao cuidado.
- **Componentes práticos:** atividade física regular, alimentação adequada, prevenção de quedas, vacinação, rastreamentos adequados à idade, estímulo cognitivo, participação social e combate à solidão.
- **Vínculo:** relações afetivas, familiares e comunitárias, e o vínculo com a equipe de saúde (longitudinalidade da APS) como fator de proteção.
- **Direitos:** Estatuto da Pessoa Idosa e Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher (PNAISM). O cuidado deve preservar a autonomia e o protagonismo da mulher nas decisões sobre o próprio corpo.

Fala de encerramento

"Para concluir minha parte: o hipoestrogenismo tem repercussões reais e mensuráveis no coração, na mente e na sexualidade. Mas o desfecho depende de genética, hábitos, contexto social e acesso ao cuidado. Cabe ao médico unir fisiologia, prevenção, escuta qualificada e cuidado longitudinal, olhando a mulher no climatério não como 'uma deficiência hormonal a corrigir', mas como uma pessoa em transição, com direito a qualidade de vida, prazer e autonomia."

Possíveis perguntas da banca (tópico 5)

1. **Diferença entre os sintomas vasomotores e a SGM na evolução natural?** Os vasomotores tendem a melhorar com os anos. A SGM é progressiva e não regride sem tratamento.
2. **O estrogênio vaginal em baixa dose exige progestagênio para proteção endometrial?** Em geral não, porque a absorção sistêmica é mínima.
3. **O que é desejo responsivo?** É o desejo que surge depois do estímulo e da intimidade (modelo de Basson). Não é disfunção.
4. **Qual modelo orienta a abordagem sexual na consulta?** O PLISSIT.

Referências para citar na banca

- Ministério da Saúde. *Manual de Atenção à Mulher no Climatério/Menopausa*. Brasília, 2008.
- FEBRASGO. *Manual de Climatério*, edição mais recente.
- The Menopause Society (antiga NAMS). Position Statement on Hormone Therapy (2022) e Nonhormone Therapy (2023).
- El Khoudary SR et al. Menopause Transition and Cardiovascular Disease Risk, AHA Scientific Statement. *Circulation*, 2020.
- Estudo SWAN (Study of Women's Health Across the Nation), publicações sobre lipídios, sono, humor e cognição.
- Diretrizes da SBC sobre dislipidemia e prevenção cardiovascular, e Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial (2025).
- Basson R. The female sexual response: a different model. *J Sex Marital Ther*, 2000.
- Portman DJ, Gass ML. Genitourinary syndrome of menopause. *Menopause*, 2014.
- OMS. *Envelhecimento Ativo: uma política de saúde* (2002) e *Década do Envelhecimento Saudável 2021-2030*.
- Stewart M et al. *Medicina Centrada na Pessoa (MCCP)*.

Antes de apresentar

Em cada slide, deixe na tela só os tópicos-chave e use o restante como fala. A banca costuma valorizar três coisas:

1. O aluno citar o SWAN.
2. Saber responder que a THM não previne doença cardiovascular.
3. Mostrar uma visão multifatorial, sem reduzir tudo ao hormônio.